

약제급여평가위원회 평가 결과

Indium(111In) chloride sol. 1mCi(37MBq),
Pentetate 0.1mg

(이메딕스인덱펜테틱산주, 약진이메딕스(주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1ml/병 중 Indium(111In) chloride sol. 1mCi(37MBq), Pentetate 0.1mg

☐ **효능 효과 :**

이 약은 진단용으로만 사용한다.

- 뇌수조 신티그래피 :

뇌척수 폐색 감지

정상압 수두증(물뇌증)과 그 외의 수두증(물뇌증)의 구별

- 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2013년 제2차 약제급여평가위원회: 2013년 2월 21일

- 중앙심사조정평가위원회 심의일: 2012년 3월 12일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “뇌수조 신티그래피(뇌척수 폐색감지, 정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별), 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)”에 허가받은 약제로, ‘정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별에 CT 또는 MRI 검사가 금기이거나 CT 또는 MRI로 진단이 불가능한 경우’에 임상적 유용성이 인정되나 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “1.뇌수조 신티그래피: 뇌척수 폐색감지, 정상압수두증(물뇌증)과 그 외의 수두증(물뇌증)의 구별, 2. 뇌척수액의 누출 감지(콧물 또는 이루)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않는 점 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 행위 급여 목록에 등재되어 있는 방사성 동위원소 뇌조조영술에 사용하도록 허가 받은 유일한 약제임.
- 중추신경계 장애를 진단하기 위해 CT, MRI가 많이 사용되지만 이와 같은 방법으로 진단이 되지 않는 경우 방사선적 진단을 실시하도록 권장되고 있고²⁾, 뇌조조영술(cisternography)은 뇌척수액의 동역학(kinetics)을 관찰하고 수두증의 유형을 평가하는데 있어 보조적인 역할을 하는 진단적 특이성이 있음³⁾.
- 정상압수두증은 치매의 원인 질환 중 하나로 뇌척수액 단락(shunt)으로 치료 가능한 질환임. 40~60%의 환자에서 수술 후 호전을 보인다는 점에서 정상압수두증에 의한 치매와 퇴행성 치매의 감별은 매우 중요하며, 방사성동위원소 뇌조조영술이 진단에 유용함⁴⁾.
- 학회에서는 인덱스를 이용한 방사성 동위원소 뇌조조영술은 VP(ventriculo-peritoneal) shunt 등으로 증상이 호전될 수 있는 정상압수두증과 그 외의 수두증의 구별에는 CT나 MRI로는 확진에 있어 대체가 불가능한 검사법이라는 의견임⁵⁾.
- 중앙심사평가조정위원회에서는 ‘정상압 수두증과 그 외의 수두증의 구별’에 ① CT 또는 MRI 검사에 금기인 경우, ② CT 또는 MRI 검사도 진단이 불가능한 경우 진료 의사의 사유서 첨부 시 급여를 인정하는 것이 타당하다는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 급여목록에 동일한 적응증에 허가받은 약제는 없으며, 현재 방사성동위원소 뇌조조영술에 사용하는 ^{99m}Tc -DTPA⁶⁾는 신장신티그래피에 의한 신장 질환 진단에 허가된 약제이므로 대체 가능한 약제는 없음.
- 신청품의 1회 소요비용은 신청약가와 행위 비용을 합산한 ■■■■■ 원임⁷⁾.
- 제약사에서는 비용효용 분석자료(전체 검사 환자에 대한 ICER ■■■■■ 원/QALY, 검사로 인한 확진환자에 대한 ICER ■■■■■ 원/QALY)를 제출하였으나, 제출된 자료는 관련 지침에 따라 작성된 경제성 평가 자료가 아니며 분석관점, 모형의 구조, 모형에 사용된 가정 및 임상적 근거 등이 구체적으로 제시되지 아니함.
- 또한, 신청품은 진단용 의약품이나 진단에 대한 정확성(민감도/특이도)에 대한 정보가 없으며 모형에 반영되지 않음.

○ 재정 영향⁸⁾

- 해당 적응증의 대상 환자수⁹⁾는 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원임.
- 다만, 제약사 제출 예상 사용량은 연간 ■■■■건 기준이고 대상 환자수(건수) 감소 시 절대재정소요금액도 감소할 것으로 보임.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되어 있지 않음.
- 다만, 함량이 상이한 품목은 미국, 일본에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 기 결정신청 시 심의되었음.
- 2) Imaging of skull base cerebrospinal fluid leaks in adults, 2008, Radiology
- 3) Nuclear Medicine 2nd ed(2006)
- 4) 고창순 핵의학 제3판(2008), 고려의학
- 5) 대한핵의학회(■■■■■)
- 6) 싱코르 디티피에이테크네툼 주[®]
- 7) 신청약가 + 행위 비용(방사성 동위원소 뇌조조영술 점수 1,250.59 x 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 의료기간 중 병원, 요양병원 및 종합병원 점수당 단가 67.5원)
- 8) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

- 9) 급여기준(안)에 의한 수두증 환자를 대상으로 한 2011년 EDI 청구환자수 [] 상병으로 뇌조조영술(HC020) 행위를 청구한 환자수]
- 10) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: , 2차년도: , 3차년도:)
- 11) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상사용량 x 신청품 소요비용